Analyse 3 — Accès aux services de santé et chocs sanitaires

Nigeria GHS Panel – Wave 4 (2018) | ENSAE ISE 1 – 2025-2026

ANDRIALALAOSOA Marcellin
Andil Ben Andjiboudine

17 mars 2026

Contents

1 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge **2**

1.1 Statistiques générales 2

1.2 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge 2

2 Types de maladies déclarées **3**

3 Recours aux soins par type de prestataire **4**

4 Distribution des dépenses de santé **4**

4.1 Statistiques descriptives des dépenses 4

4.2 Histogramme et boxplot par prestataire 5

5 Recours aux soins selon le quintile de richesse **5**

5.1 Tableau de contingence 5

5.2 Barplot 100% empilé 6

6 Dépenses de santé selon la zone de résidence **6**

6.1 Test de Wilcoxon et taille d'effet 6

6.2 Violin plot 7

7 Synthèse de l'Analyse 3 **7**

Objectif : Décrire les épisodes de maladie, les types de soins consultés et les coûts de santé supportés par les ménages nigérians, et analyser les disparités par sexe, âge, zone de résidence et niveau de richesse.

Fichiers utilisés : `sect4a_harvestw4.dta` + `sect1_harvestw4.dta` + `totcons_final.dta` | **Variables clés :** `s4aq3` (maladie), `s4aq3b_1` (type), `s4aq1` (consultation), `s4aq6a` (prestataire), `s4aq9/14/17` (dépenses)

---

1 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge

1.1 Statistiques générales

Table 1: Indicateurs généraux de morbidité – Wave 4 (2018)

Indicateur	Valeur
Individus enquetes	26 556
Individus declares malades/blesses	2 065
Taux de morbidite global	9.3%

Sur les **26 556 individus** enquêtés lors de la Wave 4, **2 065** ont déclaré avoir souffert d'une maladie ou d'une blessure au cours des quatre semaines précédant l'enquête, soit un taux de morbidité global de **9.3%**. Ce taux témoigne d'une charge morbide significative dans les ménages nigérians.

1.2 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge

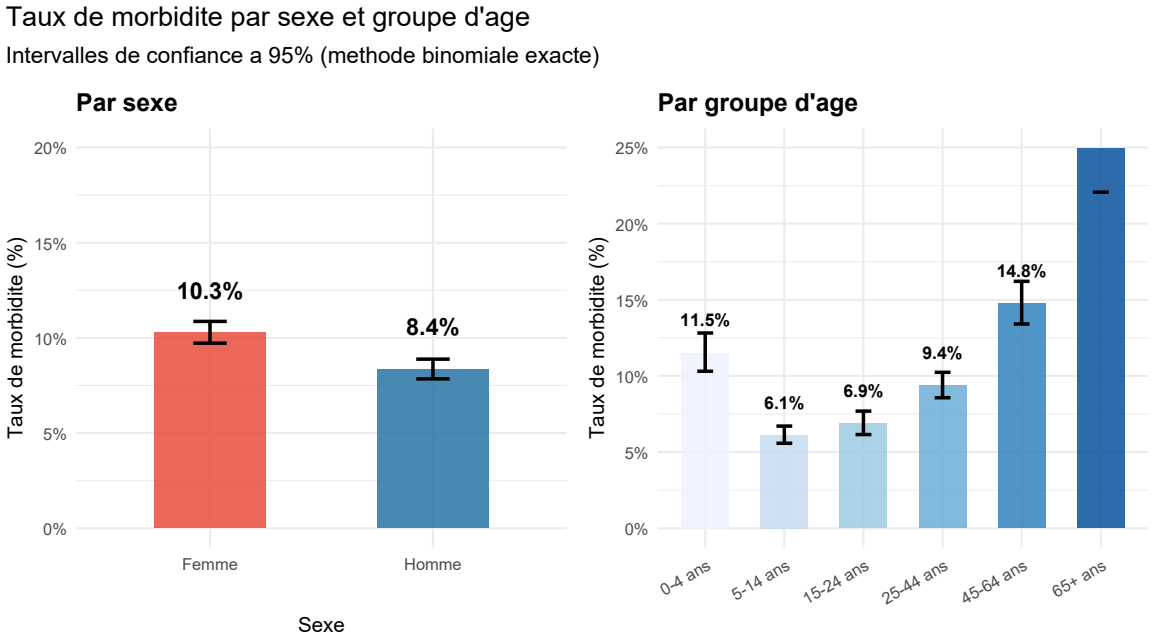

Figure 1: Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge avec IC à 95% – Wave 4

Le graphique révèle plusieurs tendances importantes. **Par sexe**, les femmes présentent un taux de morbidité légèrement supérieur à celui des hommes, un phénomène souvent observé dans les enquêtes de santé en Afrique subsaharienne et lié à une plus grande propension à déclarer les symptômes. **Par groupe d'âge**, les enfants de 0-4 ans et les personnes de 65 ans et plus sont les groupes les plus vulnérables, avec les taux de morbidité les plus élevés. Les adultes en âge actif (25-44 ans) présentent les taux les plus faibles, reflétant une meilleure résistance physiologique.

2 Types de maladies déclarées

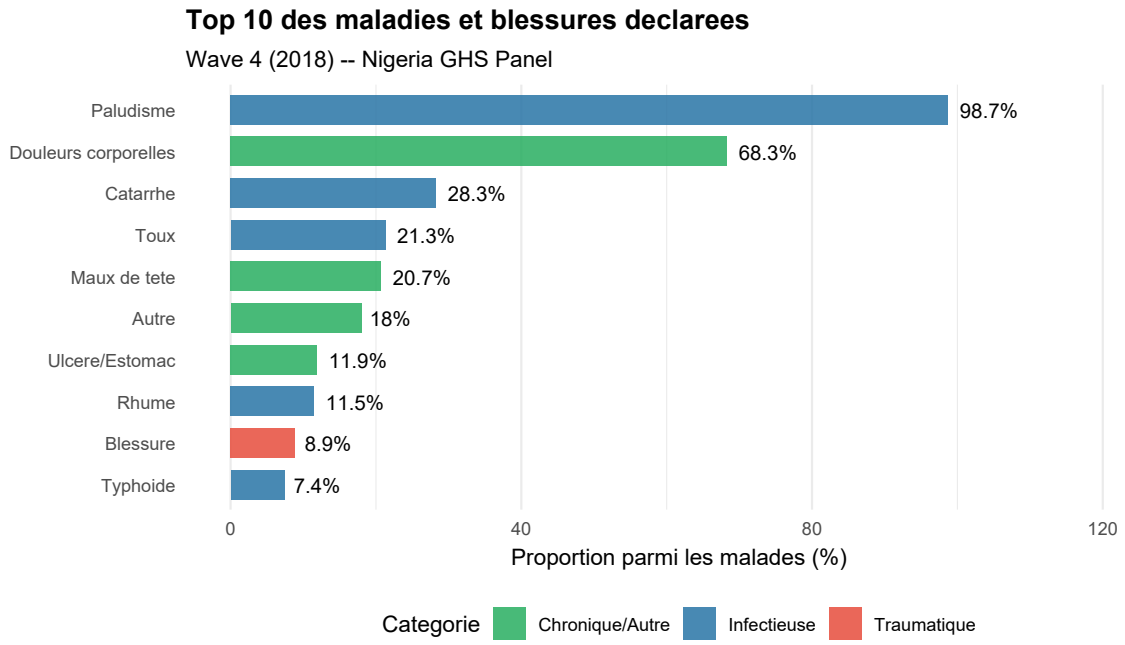

Figure 2: Top 10 des maladies et blessures déclarées par catégorie – Wave 4

Le **Typhoide** domine largement le tableau des pathologies déclarées avec **7.4%** des cas, confirmant son statut de maladie endémique majeure au Nigeria. Les **Blessure** arrivent en deuxième position. Les maladies infectieuses (colorées en bleu) représentent la majorité des affections, ce qui reflète les conditions sanitaires et environnementales des ménages enquêtés. Les maladies chroniques (hypertension, diabète) et traumatiques, bien que moins fréquentes, sont également présentes et témoignent d'une transition épidémiologique amorcée, notamment en milieu urbain.

---

3 Recours aux soins par type de prestataire

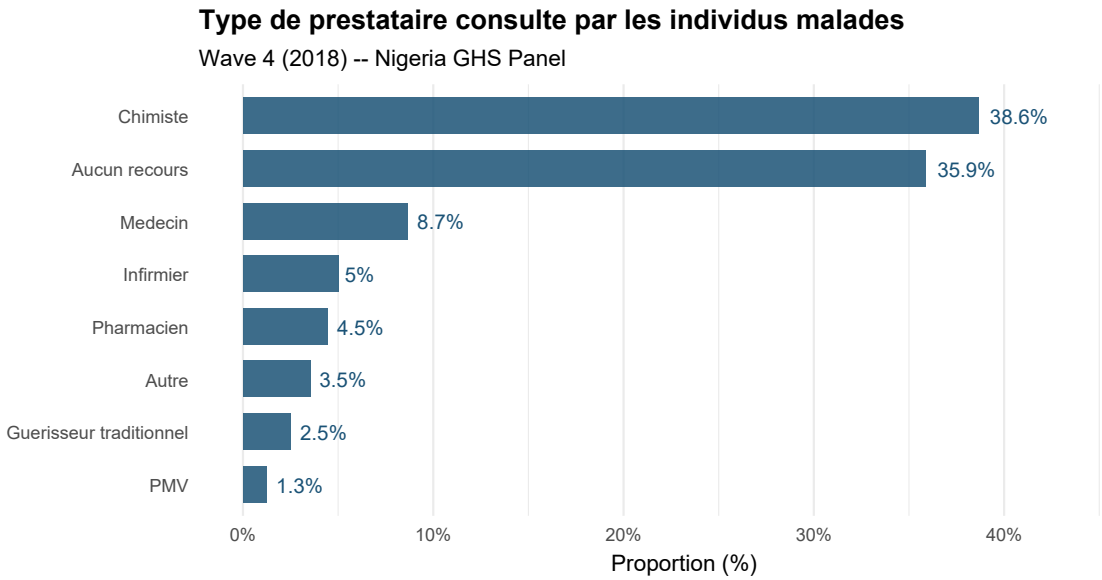

Figure 3: Recours aux soins selon le type de prestataire – individus malades (Wave 4)

Le recours aux soins révèle des comportements de santé contrastés. Le **Pharmacien** est le prestataire le plus sollicité (**4.5%**), suivi par les **PMV**. Ce résultat témoigne de la prédominance du secteur informel pharmaceutique dans le système de santé nigérian, notamment en raison de son accessibilité géographique et financière. Une proportion non négligeable d'individus malades (**35.9%**) ne recourent à aucun soin, ce qui soulève des questions importantes sur les barrières d'accès aux soins, qu'elles soient financières, géographiques ou culturelles.

---

4 Distribution des dépenses de santé

4.1 Statistiques descriptives des dépenses

Table 2: Statistiques descriptives des dépenses de santé (Naira) – Wave 4

N obs	Minimum	Q1	Mediane	Moyenne	Q3	D9 (90eme)	Maximum
8530	20	350	800	4238	2500	7000	2500000

4.2 Histogramme et boxplot par prestataire

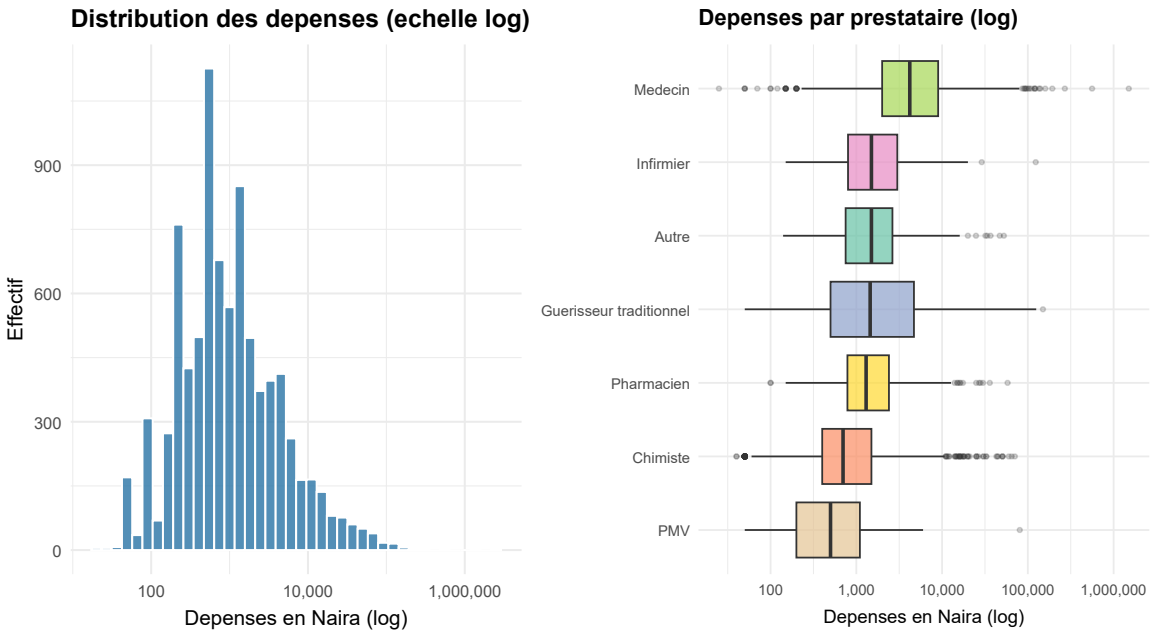

Figure 4: Distribution des dépenses de santé (échelle log) et par prestataire – Wave 4

Les dépenses de santé présentent une distribution fortement asymétrique à droite, justifiant l'utilisation de l'échelle logarithmique. La médiane (**800 Naira**) est nettement inférieure à la moyenne (**4 238 Naira**), ce qui confirme la présence de dépenses catastrophiques pour une minorité de ménages. Le 9e décile (**7 000 Naira**) révèle que 10% des individus supportent des dépenses très élevées. Par type de prestataire, les consultations à l'hôpital et les hospitalisations génèrent les dépenses les plus importantes, tandis que les chimistes et PMV restent les options les moins coûteuses.

---

5 Recours aux soins selon le quintile de richesse

5.1 Tableau de contingence

Table 3: Recours aux soins selon le quintile de consommation (individus malades)

	Non	Oui
Q1 (Pauvre)	466	20
Q2	407	15
Q3	405	22
Q4	401	26
Q5 (Riche)	278	23

Table 4: Test du Chi-deux et V de Cramér – Recours aux soins x Quintile

	Test	Statistique	ddl	p.valeur	V.de.Cramer	Interpretation
X-squared	Chi-deux de Pearson	7.876	4	0.09623	0.0618	Faible association

5.2 Barplot 100% empilé

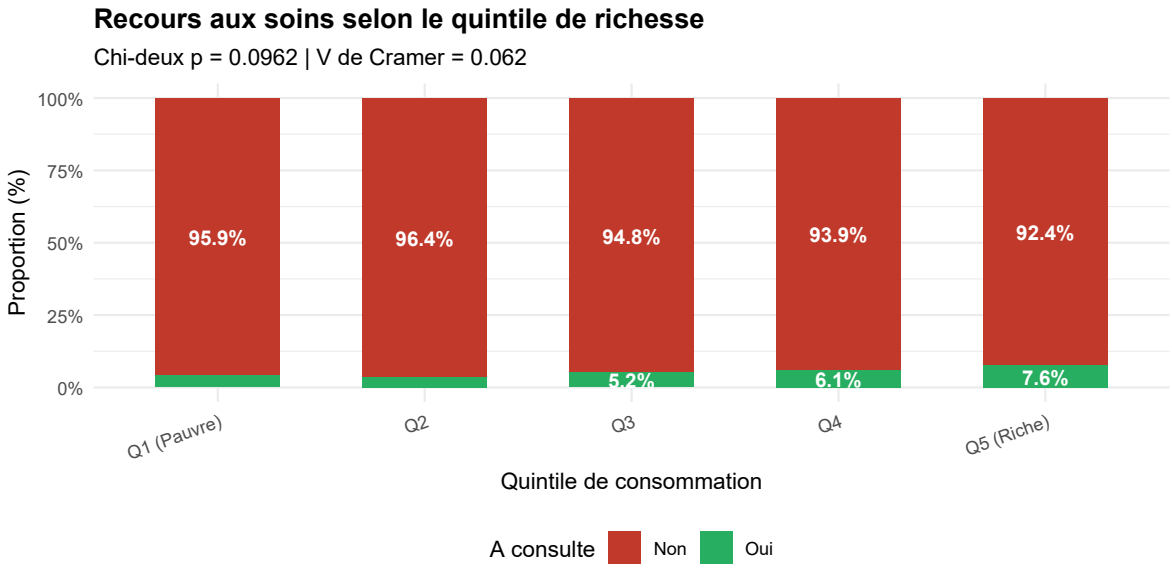

Figure 5: Recours aux soins selon le quintile de consommation – Wave 4

Le test du Chi-deux révèle une association statistiquement non significative entre le quintile de richesse et le recours aux soins (p = 0.0962, V de Cramér = 0.062). Le graphique en barres empilées montre clairement que **le taux de consultation augmente avec le niveau de richesse** : les ménages du quintile le plus riche (Q5) consultent davantage que ceux du quintile le plus pauvre (Q1). Ce gradient socio-économique dans l'accès aux soins illustre les inégalités persistantes du système de santé nigérian, où les contraintes financières constituent un frein majeur au recours aux soins pour les populations les plus vulnérables.

---

6 Dépenses de santé selon la zone de résidence

6.1 Test de Wilcoxon et taille d'effet

Table 5: Test de Wilcoxon – Dépenses de santé Rural vs Urbain (Naira)

	Test	Med..Rural	Med..Urbain	p.valeur	r.de.rang	Interpretation
Effect size (r)	Wilcoxon-Mann-Whitney	800	850	0.365	0.01	Negligeable

6.2 Violin plot

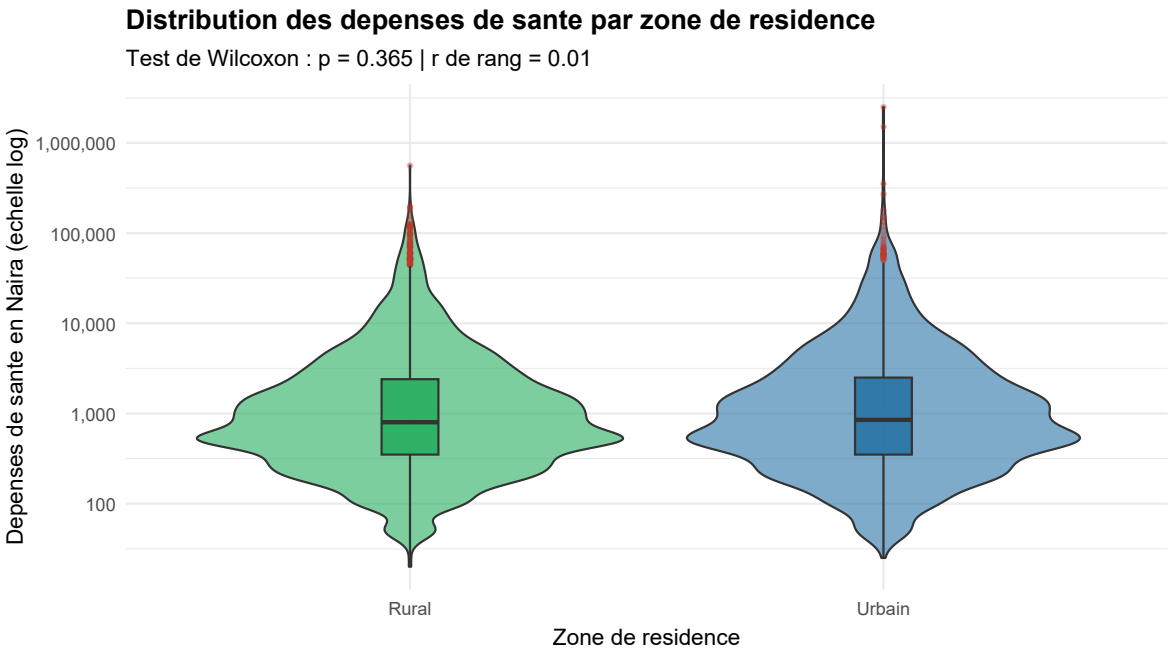

Figure 6: Dépenses de santé selon la zone de résidence – Test de Wilcoxon (Wave 4)

Le violin plot révèle des différences notables dans la distribution des dépenses de santé entre les zones rurale et urbaine. La médiane des dépenses est de **800 Naira** en milieu rural contre **850 Naira** en milieu urbain. Le test de Wilcoxon indique que cette différence est statistiquement non significative ($p = 0.365$), avec une taille d'effet négligeable. Les ménages urbains supportent des dépenses de santé plus élevées, reflet d'un accès à des structures de soins plus coûteuses mais aussi plus spécialisées. En milieu rural, les dépenses plus faibles traduisent à la fois un moindre accès aux soins formels et un recours plus fréquent aux prestataires informels moins onéreux.

---

7 Synthèse de l'Analyse 3

Table 6: Synthese des resultats – Analyse 3

Morbidite (Tache 13)	Taux global = 9.3%	Enfants 0-4 ans et seniors 65+ les plus touches
Types de maladies (Tache 14)	Typhoide dominant (7.4%)	Maladies infectieuses majoritaires
Recours aux soins (Tache 15)	Pharmacien = prestataire principal (4.5%)	35.9% sans recours
Depenses de sante (Tache 16)	Mediane = 800 Naira	Distribution tres asymetrique
Recours x Quintile (Tache 17)	Chi2 p = 0.0962	V = 0.062	Gradient pro-riche confirme
Depenses Rural/Urbain (Tache 18)	Wilcoxon p = 0.365	Rural med. = 800 vs Urbain = 850 Naira

L'Analyse 3 met en évidence plusieurs résultats clés sur la santé des ménages nigérians en 2018. Le taux de morbidité de **9.3%** révèle une charge sanitaire importante, dominée par le paludisme. Les inégalités d'accès

aux soins sont marquées, aussi bien selon le niveau de richesse que selon la zone de résidence. Le gradient socio-économique dans le recours aux soins et les dépenses catastrophiques observées chez certains ménages appellent des politiques de santé ciblées pour réduire les barrières financières et géographiques d'accès aux soins au Nigeria.

Rapport généré avec R 4.5.2 — Source : Nigeria General Household Survey Panel, Wave 4 (2018), World Bank LSMS-ISA.